

Icterícia neonatal · abordagem

Separe icterícia fisiológica de patológica pelo tempo de início, ritmo de subida e presença de sinais de alarme. Kernicterus é a complicação a evitar.

Quando é patológica

- Início < 24 h de vida
- Subida rápida (ex.: > 5 mg/dL/dia) ou nível muito alto
- Hepatoesplenomegalia, anemia, colúria/acalolia (pensar colestase se direta !)
- Sinais neurológicos: letargia, hipotonia, choro agudo

Causas de alto rendimento

Grupo | Exemplos

Hemólise | Incompatibilidade ABO/Rh, G6PD, esferocitose

Aumento entero-hepático | Baixa ingestão / desidratação, icterícia do leite materno

Hepática / colestase | Infecção, atresia de vias biliares (bilirrubina direta)

Outras | Hipotireoidismo, hematomas, sepsse

Fototerapia

Dica - Fototerapia

Indicação pelo nomograma (idade em horas × fator de risco). Exsanguíneo-transfusão se níveis críticos ou sinais de encefalopatia bilirrubínica.

Início nas primeiras 24 h = patológica até prova em contrário.



Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Icterícia com predomínio de bilirrubina direta não é 'fisiológica' e não se resolve só com fototerapia — investigue colestase (ex.: atresia biliar).

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Nomograma de Bhutani (idade em horas × risco) e limiares conceituais de fototerapia/exsanguíneo evitam kernicterus e icterícia 'fisiológica' mal classificada.

Ideia Bhutani: bilirrubina plotada por horas de vida e zona de risco define fototerapia vs observação.

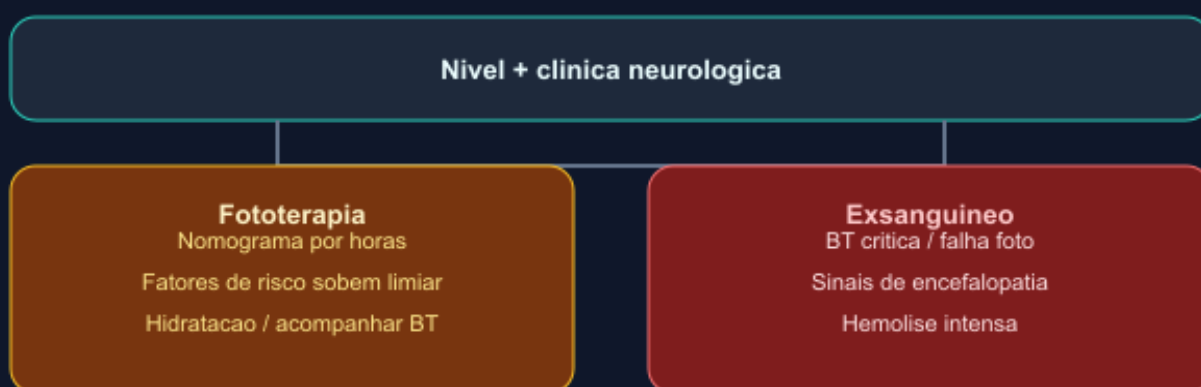
Icterícia por tempo

Início guia urgência



Fototerapia sobe com idade em horas e fatores de risco; exsanguíneo se nível crítico ou encefalopatia.

Fototerapia vs exsanguíneo



Fisiológica × patológica

Pista | Fisiológica | Patológica

Início | Após 24 h | < 24 h

Velocidade | Lenta | Subida rápida / nível alto

Direta | Normal | ! direta = colestase até prova em contrário

Clínica | RN bem | Anemia, hepatoespleno, toxemia, neuro

Conceito Bhutani / conduta

- Eixo X = horas de vida; eixo Y = bilirrubina total; zonas de risco guiam conduta
- Fatores de risco (prematuridade, hemólise, asfíxia, sepse) abaixam limiar de tratamento
- Exsanguíneo: níveis críticos ou sinais de encefalopatia bilirrubínica
- Icterícia do leite materno " colestase: bilirrubina direta alta muda tudo

Armadilha

Atenção - Armadilha

Predomínio de bilirrubina direta não se resolve só com fototerapia — investigue colestase (ex.: atresia de vias biliares).

